·论 著·

积极成语朗读训练对脑卒中非流畅性失语患者的影响

郑河清，郑云月，陈晓玲，陈莹莹
（广东医科大学附属第二医院，广东 湛江 524000）

摘要：目的 探讨积极成语朗读训练对脑卒中非流畅性失语患者语言能力恢复的影响。**方法** 选取2020年1—6月收治于广东医科大学附属第二医院的80例脑卒中后非流畅性失语患者作为研究对象，通过简单随机将其分为观察组（n=40）和对照组（n=40）。对照组接受常规言语康复训练，观察组在此基础上接受积极成语朗读训练。干预10 d后，采用汉语标准失语症检查（选取其中的听理解、复述、说、出声读及阅读能力测试部分）及自行编制的患者满意度调查问卷，比较两组患者失语改善情况及对康复护理工作的满意度。**结果** 干预10 d后，观察组患者言语能力测评分值及对言语康复训练护理的满意度评分均高于对照组（P<0.05）。**结论** 积极成语朗读训练可有效提升脑卒中非流畅性失语患者的言语功能康复效果，提高患者满意度。

关键词：卒中；非流畅性失语；言语康复；积极；成语；朗读训练
中图分类号：R473.5 **文献标志码：**A DOI：10.3969/j.issn.1009-8399.2022.04.002

Effect of Positive Idiom Reading Training on Stroke Patients with Non-fluent Aphasia

ZHENG Heqing, ZHENG Yunyue, CHEN Xiaoling, CHEN Yingying *(The Second Affiliated Hospital of Guangdong Medical University, Zhanjiang, Guangdong 524000)*

Abstract: Objective To investigate the effect of positive idiom reading training on speech rehabilitation in stroke patients with non-fluent aphasia. **Methods** A total of 80 stroke patients with non-fluent aphasia admitted to the Second Affiliated Hospital of Guangdong Medical University from January to June 2020 were selected. They were randomly divided into the observation group (n=40) and the control group (n=40). The control group was given routine speech rehabilitation training, while the observation group received positive idiom reading training on this basis. After 10 days of intervention, the improvement in aphasia and patient satisfaction with rehabilitation nursing were compared between the two groups based on the results of the Chinese Rehabilitation Research Center Standard Aphasia Examination (subtests of listening comprehension, repetition, speaking, reading aloud and reading comprehension) and a self-developed satisfaction questionnaire. **Results** After 10 days of intervention, the scores of verbal abilities and satisfaction with speech rehabilitation training in the observation group were higher than those in the control group (P<0.05). **Conclusion** Positive idiom reading training can improve the rehabilitation effect of speech function in stroke patients with non-fluent aphasia and improve patient satisfaction.

Key Words: Stroke; Non-fluent aphasia; Speech rehabilitation; Positive; Idiom; Reading training

失语症是由脑部损伤所致的一种语言障碍，患者轻则表现为词语检索困难，重则会出现语言产生与理解困难[1]。近年来，尽管各类语言治疗方法不断涌现，但尚未发现一种可适用于所有失语症患者的言语治疗方式，也缺乏具有广泛有效性的统一的言语治疗素材[2]。针对脑卒中失语症的多样化特征，国内外研究者也在不断进行各种言语训练方式与素材研究的探索[3]。非流畅性失语是失语症的一种类型，以语速缓慢、吐词量少、言语费力为特征。该类失语症患者尚具备一定程度的理解与视听能力[4]。旋律语调治疗法可利用一定的言语韵律与节奏、重音与音调等旋律特点来协助患者提升语言产出效果[5]。成语作为汉语言体系的特有形式，具备语言结构简单、平仄韵律感与节奏

收稿日期： 2021-07-23
作者简介： 郑河清（1981—），女，主管护师，大专，主要从事康复护理工作。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

感鲜明、趣味性强等特点。其作为言语训练素材，特别是旋律语调治疗的素材，具有天然优势。本研究采用积极成语朗读训练对脑卒中非流畅性失语患者进行干预，并取得了较好效果，现报道如下。

1　对象与方法

1.1　对象　选择2020年1—6月收治于广东医科大学附属第二医院康复医学科的脑卒中后非流畅性失语患者作为研究对象。纳入标准：①经西部失语症成套测试（Western Aphasia Battery，WAB）[6]确认为非流畅性失语症；②影像学检查证实病变为左侧大脑单一病灶，首发脑卒中，且无伴发疾病；③具有初中及以上学历，意识清楚，发病前智力、精神、语言能力正常；④处于疾病稳定期；⑤对本次研究知情同意。排除存在认知、听力、构音或精神障碍者，以及双眼矫正视力小于1.0或存在视野缺损的患者。本研究共纳入患者80例，将其按收治病室号的奇偶数分为对照组（n=40）与观察组（n=40）。两组患者一般资料比较，差异无统计学意义（P>0.05），具有可比性，详见表1。

表1　两组患者一般资料比较

项目	观察组（n=40）	对照组（n=40）	t/χ^2值	P值
平均年龄（岁，$\bar{x}\pm s$）	57.60±3.79	58.80±3.51	−1.468	0.146
性别[n（%）]			0.052	0.820
男	24（60.00）	23（57.50）		
女	16（40.00）	17（42.50）		
文化程度[n（%）]			0.052	0.820
初高中/中专	23（57.50）	24（60.00）		
大专及以上	17（42.50）	16（40.00）		
失语病因[n（%）]			0.054	0.816
脑梗死	26（65.00）	25（62.50）		
脑出血	14（35.00）	15（37.50）		
NIHSS评分①（分，$\bar{x}\pm s$）	11.28±1.36	11.30±1.29	−0.085	0.933

注：①美国国立卫生研究院卒中量表（National Institute of Health Stroke Scale），用于评定卒中患者神经功能缺损程度分级，评分范围0～42分，分值愈高表明神经受损度愈严重

1.2　干预方法

1.2.1　对照组干预方法　给予患者常规言语康复训练干预，内容包括以下3方面。①呼吸调节训练：指导患者经鼻深吸气后行缩唇呼气，以此完成鼻、咽及口腔闭锁功能的训练。②发音肌肉运动训练：指导患者行鼓腮与卷舌、咀嚼与左右摆动舌头、前伸后缩舌头等舌肌与面肌的训练活动。③发音练习：护士示范口型并对发音器官的位置进行说明，指导患者行“a、o、e、i、u、ü”等元音字母发音练习。

1.2.2　观察组干预方法　在对照组基础上加用积极成语朗读训练干预，参照相关研究[7]设计训练内容及方案。干预护士于项目启动前接受为期1周的专项培训，培训内容包括方案目的、起效机制、实施流程与技巧、工具选用、效果评价方式等。完成专项培训且考核合格者方可实施干预。具体干预方法如下。

1.2.2.1　积极成语素材筛选与制作　以《学生实用成语辞典》为素材来源，精心挑选出30个具备积极意义（褒义）的叠字四字成语，如文质彬彬、喜气洋洋、堂堂正正、亭亭玉立、心心相印、欣欣向荣、津津有味、恋恋不舍、落落大方、彬彬有礼等。将筛选出的成语录入电脑并制作为PPT形式的播放材料，每页一个成语，字号为170号，黑色、宋体，且以白色为底色背景突出成语。

1.2.2.2　积极成语朗读训练方式　①训练过程。护士采用手动播放模式呈现PPT中的成语，让患者尝试读出屏幕上所示成语。屏幕上每出现一个成语，即让患者大声朗读，每个成语的屏幕停留时间为12 s，过时则更换为下一个成语。当日训练结束时，请患者将当日成功朗读的成语再重复朗读一遍，做出成绩告知，引导其体会成语训练成果的喜悦；后续每日练习时先将前一日成功朗读的成语复读一遍，实现语音提取记忆的逐步增加与有效巩固。②赋分方法。患者如可完整读出一个成语计1分；不能完整读出者，按读出字的个数计分，按顺序读出一个字计0.25分，以此类推，总分计30分。吐字不清、多读、朗读顺序错误、未读、存在音素性错误均不计分。训练全程进行录音，以录音资料作为计分来源，以避免在训练过程中计分使患者产生紧张感，进而影响患者的朗读训练进程及情绪。③训练时机及频率。选择患者病情稳定且精神状态良好时开展训练，连续训练10 d，每天训练时长为60 min，可根据患者当日状态合理分次训练。④注意事项。朗读训练过程中，如患者提取成语困难时，护理人员可读出成语前两字作为语音提示，鼓励并引导患者尝试读出该成语的剩余部分；如患者仍无法完成成语朗读，护士则可对该成语进行全语音提示，并出示与该成语语境相关的彩色图片，增加刺激强度，助力患者读出或复述该成语。患者成功朗读出成语后，请其再带感情地大声复述一遍以巩固。如经上述努力，患者仍无法完成成语朗读，则先跳过该项成语，进入下一个成语的朗读训练，不要过长时间纠缠于一个成语，以防患者训练信心受挫。

1.3　评价指标

1.3.1　患者失语恢复情况　采用汉语标准失语症检查（Chinese Rehabilitation Research Center Standard Aphasia Examination，CRRCAE）[7]于干预前后对两组患者进行测试。CRRCAE由中国康复研究中心研发，已应用于国内多家康复中心及医院，并获得良好反馈。CRRCAE共包括9个测试部分，结合本研究需要，选择其中

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的5个测评部分，即听理解能力（4维度）、复述能力（3维度）、说能力（5维度）、出声读能力（3维度）及阅读能力（4维度）。各维度多数条目以1～6分计分，测试对象经提示后回答错误计1分，规定时间内正确作答计6分。其中，“说能力”测试项目中，漫画说明维度总分6分；水果列举测评维度中，每说出一个水果名称计1分。出声读能力测评部分，句子维度总分值30分。除上述之外，其余各测评项目维度总分均为60分，分值越高提示该项言语功能越好。有研究报道，该量表的Cronbach's α系数为0.941，内容效度为0.948。具体实施中，由2名经培训的护士进行测评，每次测评时间约为60 min。

1.3.2 护理满意度测评问卷 研究组成员结合失语症的特点与康复护理要求，在文献研究及咨询专家的基础上自行设计“非流畅性失语患者言语康复训练护理满意度测评问卷”。问卷包含言语训练的科学性（理论支持）、言语训练素材、言语训练方式3个方面，共6个条目，各条目从“非常不满意”到“非常满意”分别计为0～10分，各维度分值为其所含条目评分的均值，总分值为0～30分，分值愈高提示该非流畅性失语患者对言语康复训练护理的满意度愈高。责任护士于干预10 d后，向患者发放纸质问卷进行调查。共发出问卷80份，回收有效问卷80份，有效回收率为100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 23.0软件对数据进行分析和处理；符合正态分布的计量资料采用均数±标准差描，组间比较采用t检验；计数资料采用频数、构成比描述，组间比较采用卡方检验；以$P<0.05$视为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 干预前后两组患者CRRCAE检查结果比较 干预前，两组患者的听理解、复述、说、出声读及阅读能力比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。干预10 d后，两组患者5个方面的言语能力均较干预前有所提高（$P<0.05$），且观察组评分优于对照组（$P<0.05$）。详见表2。

2.2 两组患者对言语康复训练护理的满意度比较 观察组患者对言语康复训练的科学性、训练素材及训练方法的满意度评分均高于对照组（$P<0.05$），见表3。

3 讨论

3.1 积极成语朗读训练用于脑卒中患者言语康复的背景与机制 失语症系一类可严重影响脑卒中幸存者生活质量的并发症。计划性针对式言语功能训练有助于促进脑卒中后失语症患者改善或恢复言语功能[8]。素材的选择对言语训练而言十分重要。脑卒中失语症的早期言语训练，宜选择易被患者读出的训练素材，以便提升其言语康复信心，推进其步入长期、复杂、艰巨的言语功能康复通道[9]。基于旋律语调治疗法在失语症言语功能恢复中已取得的效果，本研究选择成语作为脑卒中后非流畅性失语患者的言语康复训练素材，主要是综合考量了成语本身朗朗上口、精短达意、节奏韵律感强、内含丰富的故事背景、具有广泛化的大众语

表2 干预后两组患者言语能力测评项目评分比较 （分，$\bar{x}\pm s$）

项目	条目数	分值范围	分组	组别		t值	P值
				观察组（n=40）	对照组（n=40）		
听理解	4	40～240	干预前	112.58±1.60	112.48±1.60	0.279	0.781
			干预后	154.73±1.22	138.40±1.82	47.079	<0.001
			t值	−132.549	−67.580		
			P值	<0.001	<0.001		
复述	3	30～180	干预前	82.00±1.83	81.90±2.20	0.221	0.826
			干预后	112.40±1.58	105.18±1.58	20.416	<0.001
			t值	−79.588	−54.228		
			P值	<0.001	<0.001		
说	5	30～192	干预前	56.10±1.70	56.35±1.64	−0.668	0.506
			干预后	81.83±1.71	72.80±1.44	25.581	<0.001
			t值	−67.382	−47.704		
			P值	<0.001	<0.001		
出声读	3	35～150	干预前	66.85±1.41	66.93±1.40	−0.239	0.812
			干预后	95.90±1.50	84.45±1.81	30.807	<0.001
			t值	−89.405	−48.382		
			P值	<0.001	<0.001		
阅读能力	4	40～240	干预前	100.10±3.10	99.40±2.64	1.088	0.280
			干预后	131.20±1.60	120.68±1.05	34.742	<0.001
			t值	−56.420	−47.392		
			P值	<0.001	<0.001		

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表3　两组患者对言语康复训练护理的满意度评分比较

（分，$\bar{x}\pm s$）

组别	例数	科学性	训练素材	训练方式
观察组	40	9.30±0.65	9.28±0.64	9.28±0.64
对照组	40	7.30±0.85	7.40±0.81	7.33±0.83
t值		11.802	11.485	11.780
P值		<0.001	<0.001	<0.001

言属性等言语训练素材优势[10]。成语的声调自然形成平仄韵律，与音乐曲目音调所形成的旋律具有异曲同工之妙。之所以选择叠字四字成语作为训练素材，主要是考虑到朗读时叠字音节可获自然延长与重复发音，可减慢与缓冲患者的朗读发音速度，增强其吐字清晰度，使患者获得有效分辨各音节的机会，降低对左侧大脑的依赖度。且成语朗读极富节奏性，两字成一节拍，患者在完成前两字朗读后会自然出现一个短暂停留期，使其有较为充裕的时间做好读取下一字所需发音器官的启动及语音提取的准备工作，可主动调节患者的朗读速度，缓解其因任务压迫所致的内心紧张[11]。与此同时，成语本身蕴含相应的背景故事，患者在朗读成语时还可自然回顾其背后的故事情境，趣味性较高。成语相关性彩色图片的播放，也可帮助患者通过图片所示主动开展成语内涵理解活动，使其理解能力及联想能力得到一定训练。本研究特意选取蕴含积极语义的成语素材，使患者在朗读过程中投入感情、获得积极信息渗透，有助于增强患者的训练信心与训练愉悦感受。除此之外，成语具有大众化语言使用习惯的广泛性基础，会使人在头脑中形成稳定编码信息源。非流畅性失语患者主要是语音编码的提取能力受损及口语输出障碍，而其头脑中仍保留有一定的语音编码信息。积极成语朗读训练正是针对语音编码提取能力恢复而设计，且因其与患者头脑中已有信息编码存在相合性，故更易被患者所接受。

3.2　积极成语朗读训练在脑卒中言语康复中的实施效果　表2显示，观察组患者干预后的5项言语能力测评分值均高于对照组（$P<0.05$）。可见，选取具有积极语义的叠字四字成语作为训练素材，对提升非流畅性失语患者的言语功能康复训练效果有积极促进作用。同时，表3显示，观察组患者对于积极成语朗读康复训练的满意度较对照组更高（$P<0.05$）。积极成语朗读训练是基于旋律语调治疗理论设计而成，理论基础扎实；且精心选择大众语言习惯体系中常用的具有积极语义的叠字四字式成语作为言语训练素材，可充分发挥叠字、积极语义成语素材的优势。合理训练素材的选择、强调循序渐进及回馈巩固的训练方式，可有效激发与维护患者的训练信心，提升其训练依从性，进而可增加患者在训练活动中的受益度、提高满意度。

4　小结

脑卒中并发失语症可对患者的生活质量产生较大负面影响。积极成语朗读训练简单易行，且可使脑卒中非流畅性失语患者获得良好的言语功能康复训练效果，提升其满意度，不失为一种可推广的脑卒中失语症患者康复护理方案。

参考文献：

[1] 曹蕙，王芳.阶段性语言康复训练在脑卒中后失语症患者中的应用[J].上海护理，2020，20(9)：36-38.
[2] 刘海梅，冶学兰，张成辉，等.不同频率重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的效果观察[J].现代生物医学进展，2019，19(22)：4384-4387.
[3] 朱晓菊，何小俊.音乐疗法治疗脑卒中失语症的研究进展[J].护理研究，2020，34(2)：288-290.
[4] 陈艳，高汉雄，王璇，等.低频rTMS对脑卒中恢复期非流畅性失语症患者语言及交流能力康复的影响[J].中国老年学杂志，2020，40(4)：709-712.
[5] 王莹娜，何小俊.联合式言语训练手册在脑卒中非流畅性失语症病人言语康复中的应用[J].护理研究，2020，34(5)：925-928.
[6] JOHN A A，JAVALI M，MAHALE R，et al. Clinical impression and Western Aphasia Battery classification of aphasia in acute ischemic stroke：is there a discrepancy [J]. J Neurosci Rural Pract，2017，8(1)：74-78.
[7] 张庆苏，纪树荣，李胜利，等.中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析[J].中国康复理论与实践，2005，11(9)：703-705.
[8] 郭连荣.注意康复训练对脑卒中失语症患者语言功能和注意力水平的影响[J].护理实践与研究，2019，16(7)：153-155.
[9] 王莹娜，何小俊.言语康复训练工具在脑卒中失语症中的应用研究进展[J].现代临床护理，2019，18(3)：58-63.
[10] 陈宸，谢瑛，吴春薇，等.旋律发音治疗对脑卒中早期非流畅性失语患者言语失用的影响[J].临床和实验医学杂志，2020，19(5)：502-505.
[11] 朱洁，梁玲毓，黎景波，等.旋律语调疗法在非流畅性失语康复中的应用[J].康复学报，2017，27(5)：34-37,41.

（本文编辑：裴　艳）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net